

24/09

INDICADO POR: Dr.º Raphael (Neuro)

X ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

GABRIEL MOREIRA DE SOUZA - Trissomia 21

IDADE: 24 PESO: 80 ALTURA: 156 PROFISSÃO: estudante - Assim

SINTOMAS: Sonolência diurna / Tive apneia e cianose
acumulo de saliva na boca.

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Mecobal / Orga noreuro / Vita Colin / Betriat / Zimbal

MÉDICO: Dr.º Raphael Fornaciari / Dr.º Eduardo Piracudini (P)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N Dr.º André (otori)

EXERCÍCIO FÍSICO: Zumbao / Rip Top

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (20)

HORA QUE DORME: 22 HORA QUE ACORDA: 4:30

COCHILHO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: () S (X) N () EVENTUALMENTE Pai Renca

TEM FILHOS: () S (X) N / DORMEM NO QUARTO: (X) S () N PET NO QUARTO: (X) S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA XN

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 0 X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IV IAH: 18.1% SPO2: 86% IDO (21.7)

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Rinite 5.7% 88%
IDO (4.1%)

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA (S) CARDÍACA CIV (corrigida)

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS: cl 1 ano

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N SPO2 C/ CPAP: 88% PRESSÃO NO EXAME: 9cmH₂O06/06 - Avaliação
25

marc. D Pillow

12/06 P = 7.6 cmH₂O AC = 14.7
25 IAH = 20.4% AO = 2.2
m. de uso: 9 IH = 3.3
fuga: 10 lpm30/06 P = 7.6 cmH₂O AC = 10.6
25 IAH = 16.9% AO = 3.5
m. de uso: 9h22' IH = 2.5
fuga = 0.6 lpm

21/06/25

Depa Kerre - 250mg
2x dia

fua cláudia



INSTITUTO DO CÉREBRO,
CLÍNICA DA MEMÓRIA

Dr Raphael Fornaciari
Neurologia Clínica
CRM 216591

PACIENTE:

Gabriel Moreira de Souza

ENDEREÇO:

Paciente acima descrito apresenta necessidade
do uso de Cpap devido ocorrência de apnéia
obstrutiva do sono; o paciente é portador
de Síndrome de Down apresentando
alterações anatómicas nas vias aéreas que
culminam na redução do diâmetro onde
passa o ar enquanto dorme, podendo evoluir
com crise convulsiva caso a saturação
de oxigênio fique muito baixa.

03/ Junho/2025

Rua Santa Clara, 450 - CEP 12243-630
Vl. Adyana - São José dos Campos - SP
Tel. (12) 3202-8080

Dr. Raphael Fornaciari
Neurologia Clínica
CRM 216591

Questionário de Sono e escala

melhor pressão

Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: GABRIEL MOREIRA DE SOUZA

Data do Exame: 19-05-2025

pág. 2

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Saturação da oxi-hemoglobina (86%);
2. Ligeiro aumento da latência para o início do sono (30,5 min) (VN= 5 a 30 min);
3. Latência para o início do sono REM normal (86,5 min) (VN= 70 a 120 min);
4. Eficiência do sono reduzida (82,2 %) (VN= $\geq$ 85%);
5. Índice de despertares normal (13,4 n^o/h) (VN= até 15 n^o/h);
6. Percentual do estágio N1 normal (3,3 %) (VN= 2% a 5%);
7. Aumento do percentual do estágio N2 (63,2 %) (VN= 45% a 55%);
8. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (15,4 %) (VN= 13% a 23%);
9. Diminuição do percentual do estágio REM (18,1 %) (VN= 20% a 25%);
10. Ronco constante verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

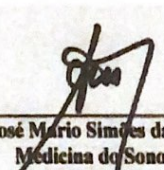
Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9 cmH₂O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: GABRIEL MOREIRA DE SOUZA

Sexo: Masculino

Data do Exame: 29-04-2025

Idade: 24 anos

Peso: 80 kg

Altura: 1,56 m

Médico Solicitante: DR. RAPHAEL FORNACIARI

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 29/04/2025 22:03 e finalizado às 30/04/2025 05:47.

A latência para início do sono foi de 0,0 min e a latência para o sono REM de 95,0 min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 402,0 min, com eficiência do sono de 86,7 %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou 3,6 % de estágio N1, 52,0 % de estágio N2, 21,4 % de estágio N3 e 23,0 % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 61,5 min. Ocorreram 83 despertares, sendo o índice de 10,7 (nº/h).

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 7,6 (nº/h), O associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 38, sendo 3 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 35 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 5,7 (nº/h). O IDR durante o sono REM foi de 4,5 e o IDR durante o sono NREM foi de 6,0. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 5,7 (nº/h), sendo 0,4 apneia/h e 5,2 hipopneia/h.

A saturação da oxí-hemoglobina (SAO₂) basal foi 96%, a média de 95% e a mínima de 88%.

O índice de dessaturação da oxí-hemoglobina (IDO) foi de 4,1 (nº/h), sendo que em REM foi de 3,9 (nº/h) e em NREM foi de 5,0 (nº/h). Permaneceu 0,3 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Nome: GABRIEL MOREIRA DE SOUZA

Data do Exame: 29-04-2025